Prévention de la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B : l'apport du Service d'hépato-Gastroentérologie du CHU Sourô Sanou

Nom du présentateur : **Mâli KOURA**

Auteurs : **Mâli KOURA**[1,2], Delphine P ZONGO-NAPON[1,2], Kadidiatou O Ouattara[2], Nogogna ZOURE[1], Appolinaire SAWADOGO[1,3].

1. Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS)
2. Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA).
3. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS).

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction 1/3

- **Hépatite Virale B:** Problème majeur de santé publique dans le monde (**OMS**)
- **OMS en 2022,**
  - 254 millions de porteurs chroniques dans le monde
  - 1,2 million de nouvelles infections signalées chaque année
  - 1,1 million de décès dans le monde, **cirrhose ou carcinome hépatocellulaire**
- **Burkina Faso**
  - Prévalence portage AgHBs : 9,1% (Meda et coll; 2017)

Introduction 2/3

❑ Burkina Faso

- ❖ Prévalence transmission mère-enfant parmi les mères AgHBs (+) : 37,1% (Sangaré et coll)
- ❖ Prévalence VHB enfants de moins de 5 ans au BF: 1,7% (OMS, 2021)
- ❖ Vaccination contre Hépatite B et inclusion P.E.V, progrès important dans l'élimination transmission périnatale du VHB

Introduction 3/3

- **Burkina Faso**
  - Plusieurs actions et stratégies entreprises dans le but de prévenir la TME du VHB
  - Peu de données disponibles au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, évaluer la stratégie utilisée pour prévenir TME en milieu hospitalier.

Objectif 1/1

Etudier la prévention de la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou

Matériel et méthode(s) 1/4

- **Cadre et champ de l'étude**
  - Service d'Hépato-Gastro-Entérologie et centre assaut hépatite,
  - laboratoire d'immunologie du CHUSS
- **Type et période d'étude**:
  - étude descriptive analytique à collecte de données prospective et rétrospective de 2015 à 2024
  - Les données ont été collectées sur une période de Janvier à Mars 2025.

Matériel et méthode(s) 2/4

- **Population d'étude**: Femmes enceintes infectées par le VHB et traitées ou non par le Ténofovir, ainsi que leurs enfants.
- **Critères d'inclusion** :
  - Femmes enceintes AgHBs (+) suivies PTME, accouché
  - Enfants nés de mère AgHBs (+) suivies PTME, âgés d'au moins 9 mois
- **Critères de non inclusion**
  - Perdus de vue, dossiers incomplets.
  - Morts nés, sérologie du VHB non réalisée

Matériel et méthode(s) 3/4

- **Taille de l'échantillon**: l'échantillon estimée = **113**
- **Collecte des données**
  - Dossiers des femmes de la file active suivi au service d'HGE pour portage d'AgHBs sur grossesse
  - Echantillons prélevés au CHUSS
    - acheminés au laboratoire immunologie du CHUSS pour la recherche de l'AgHBs et l'Ac anti HBc
    - Puis Assaut Hépatite pour la réalisation de la charge virale

Matériel et méthode(s) 4/4

❑ Variables étudiées

- ❖ Données cliniques (Age gestationnel, circonstances dépistage, nombre de parité, cytolyse, cholestase, prise de Ténofovir…)
- ❖ Données biologiques (AgHBs, Ac anti HBc, Charge virale)

❑ Analyse des données

L'analyse statistique a été réalisée par le logiciel RStudio version 4.2.0 et Excel 2016, le seuil de signification était $p < 0,05$

Résultats 1/10

❑ Diagramme de flux des mères et enfants pour PTME VHB

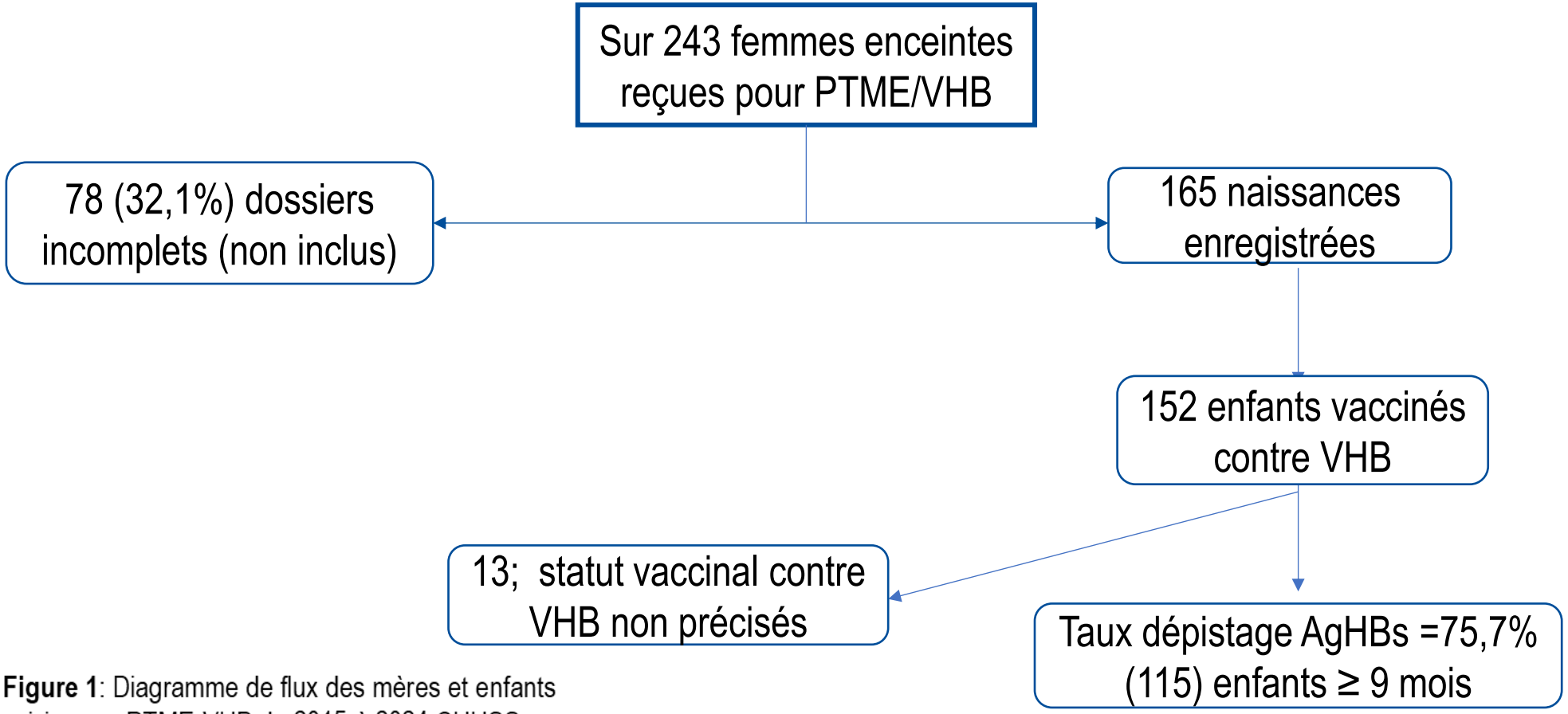

Figure 1: Diagramme de flux des mères et enfants suivis pour PTME-VHB de 2015 à 2024 CHUSS.

Résultats 2/10

❑ Circonstance de découverte du portage de l'AgHBs

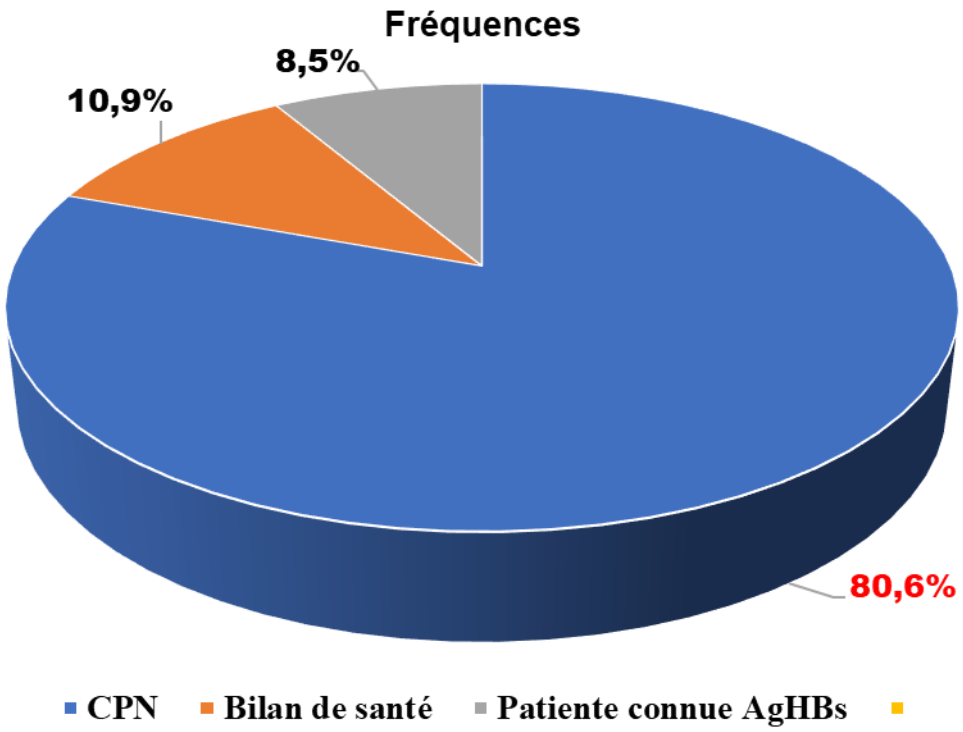

Figure 2: Répartition des patientes en fonction des circonstances de découverte

Résultats 3/10

❑ Antécédents obstétricaux

Tableau 1: Répartition des patientes selon la parité

Parité	Effectifs	Fréquences (%)
0	65	39,4
1-2	**70**	**42,4**
3-4	26	15,8
≥5	4	2,4
TOTAL	**165**	**100**

Résultats 4/10

❑ Age gestationnel au dépistage

Tableau 2 : Répartition des patientes en fonction de l'âge gestationnel au dépistage

Age gestationnel	Effectifs	Fréquences (%)
1er Trimestre	13	8
2e Trimestre	70	42,4
3e Trimestre	**82**	**49,6**
TOTAL	**165**	**100**

Résultats 5/10

❑ Caractéristiques biologiques et paracliniques patientes

Tableau 3: Répartition des patients selon les caractéristiques biologiques

Caractéristiques biologiques	Effectifs	Fréquences (%)
Positivité AgHBe	8	4,9
Coïnfection VHC	1	0,6
Coïnfection VHD	1	0,6
Cytolyse hépatique	6	3,6
Cholestase	1	0,6

Résultats 6/10

❑ Caractéristiques biologiques et paracliniques patientes

Tableau 4: Répartition des patients selon les valeurs de la charge virale (n = 92)

Quantité d'ADN (UI/mL)	Effectifs	Fréquences (%)
Indétectable (<90)	33	36
<2000	**36**	**39**
[2000-200000]	11	12
≥200000	12	13
TOTAL	**92**	**100**

Résultats 7/10

❑ Facteurs associés à la transmission mère-enfant du VHB

Tableau 5: Répartition des patientes selon la charge virale et la durée du traitement

Durée du traitement	Fréquence des charges virales (%)		P-value
	Détectable	Indétectable	
Sans traitement	59,3	78,8	
=<1 mois	11,9	3	**0,024**
2 mois	22	6,1	
≥3mois	6,8	12,1	
TOTAL	**100**	**100**	

Résultats 8/10

❑ Facteurs associés à la transmission mère-enfant du VHB

Tableau 6: Répartition des patientes selon la charge virale et l'âge gestationnel au dépistage

Age gestationnel	Fréquence des charges virales (%)		P-value
	Détectable	Indétectable	
1er Trimestre	11,9	9	
2e Trimestre	42,4	45,5	0,9
3e Trimestre	45,8	45,5	
TOTAL	100	100	

Résultats 9/10

❑ Aspects thérapeutiques

- ❖ **Ténofovir**, principale molécule utilisée
- ❖ 71 (43%) sous traitement, 1cp/24h contre 57%
- ❖ Traitement débuté 3e trimestre 59,2%
- ❖ **Durée du traitement: 2 mois pour 33,8%**
- ❖ Age gestationnel moyen début traitement 26,9 ± 5,5 SA

Résultats 10/10

- **Aspects thérapeutiques**
  - **Vaccination des nouveau-nés:** 92,1% (152/165)
  - **Statut AgHBs des enfants vaccinés:**
    - taux de dépistage AgHBs: 75,7% (115/152) Nourrissons
    - Antigène HBs négatif chez tous les nourrissons dépistés

Conclusion 1/1

- La plupart(100%) des nourrissons dépistés n' étaient porteurs du virus de l'hépatite B malgré charges virales des mères élevées (>200000 UI/mL). Environ 4,9% des mères infectées étaient porteuses de l'AgHBe. Il y avait la coïnfection VHB/VHC et VHB/VHD.
- En somme, une efficacité de la stratégie adoptée pour prévenir la TME du VHB au Burkina Faso a été constatée.

Merci pour votre attention